

Question 70 : Troubles de l'humeur

1) Le tableau clinique d'un épisode dépressif caractérisé peut comporter :

- A- Une humeur triste
- B- Une inhibition psychomotrice
- C- Des idées délirantes
- D- Des idées suicidaires
- E- Un déficit intellectuel

Réponse : **ABCD**

2) Quelles sont les réponses exactes concernant la clinique du trouble bipolaire :

- A- La maladie peut débuter par des épisodes dépressifs
- B- Un épisode hypomaniaque suffit pour porter le diagnostic d'un trouble bipolaire type I
- C- La présence d'idées délirantes permet d'éliminer le diagnostic
- D- Un épisode maniaque ne suffit pas pour le diagnostic d'un trouble bipolaire type
- E- Un épisode hypomaniaque peut être induit par les antidépresseurs

Réponse : **AE**

3) Quels sont parmi les symptômes suivants, ceux qui appartiennent au tableau clinique de l'épisode dépressif caractérisé :

- A- Désorientation temporo-spatiale
- B- Ralentissement psychomoteur
- C- Perte des intérêts
- D- Idées de culpabilité
- E- Besoin de vérifier ce qu'on vient de faire

Réponse : **BCD**

4) Face à une symptomatologie d'allure dépressive, la pathologie organique est à rechercher si :

- A- Absence de facteur déclenchant
- B- Présence d'antécédent thymique personnels ou familiaux
- C- Présence évocatrice d'une pathologie organique
- D- Absence d'éléments confusionnels
- E- Le ralentissement, l'asthénie ou l'anorexie sont marqués sans véritable perturbation thymique

Réponse : **ACE**

5) Devant une dépression, les symptômes de haute probabilité d'une dépression bipolaire sont :

- A- Un début avant l'âge de 20 ans
- B- Des antécédents familiaux de trouble bipolaire
- C- Une hyperphagie
- D- Une anxiété psychique marquée
- E- Des plaintes somatiques

Réponse : **ABCD**

6) Une femme de 46 ans est déprimée depuis plusieurs semaines.

Parmi les données suivantes, lesquelles orientent vers une origine bipolaire :

- A- Elle est traitée pour hypertension artérielle
- B- Son père était alcoolique
- C- Son frère aîné a fait il y a 10 ans un accès maniaque
- D- Elle présente une culpabilité pathologique
- E- Elle est naturellement anxieuse et pessimiste

Réponse : **CD**

7) Quels sont les symptômes caractéristiques d'un épisode maniaque :

- A- Une hyperactivité productive
- B- Une fuite des idées
- C- Des idées de grandeur
- D- Une confusion mentale
- E- Une insomnie sans fatigue

Réponse : **BCE**

8) Concernant la douleur morale :

- A- Elle se caractérise par la perte de l'élan vital
- B- Elle se caractérise par des idées d'auto accusation
- C- Elle fait partie des caractéristiques mélancoliques
- D- Elle peut être associée à des idées d'indignité et de culpabilité
- E- Elle constitue un facteur de risque suicidaire

Réponse : **BCDE**

9) La base du traitement des troubles bipolaires repose sur :

- A- La prescription d'un neuroleptique
- B- La prescription d'un antidépresseur
- C- La prescription d'un thymorégulateur
- D- La prescription d'une benzodiazépine
- E- La prescription d'une psychothérapie cognitive et comportementale

Réponse : **C**

10) Un état dépressif est susceptible de survenir au cours de :

- A- Maladie de Parkinson
- B- Alcoolisme
- C- Traitement par des anorexigènes
- D- Corticothérapie
- E- Hyperthyroïdie

Réponse : **ABCDE**

11) Devant une mélancolie délirante chez un sujet âgé, quelle option thérapeutique est recommandée de 1^{ère} intention :

- A- Lithium + Antipsychotique
- B- Antidépresseur + Thymorégulateur+ Antipsychotique
- C- Sismothérapie
- D- Antidépresseur + Thymorégulateur
- E- Neuroleptique incisif

Réponse : **C**

12) Dans le cadre d'une inhibition psychomotrice profonde vous retenez pour évoquer une mélancolie :

- A- Hallucinations acoustico-verbales
- B- Conservation passive des attitudes
- C- Un délire d'indignité personnelle
- D- Une insomnie de la deuxième partie de la nuit
- E- Un délire d'action extérieure

Réponse : **CD**

13) Lors d'un épisode hypomaniaque, on peut voir :

- A- Une hyperactivité stérile
- B- Des conduites à risque
- C- Un délire
- D- Une réduction des besoins en sommeil
- E- Une irritabilité

Réponse : **BDE**

14) Les formes graves et les formes psychotiques de dépression peuvent être très améliorées par :

- A- Les fortes doses d'antidépresseurs tricycliques
- B- Les thérapies comportementales et cognitives
- C- Les anxiolytiques type benzodiazépines
- D- Les sismothérapies
- E- La relaxation

Réponse : AD

15) Quels sont le ou les symptôme (s) qui peuvent s'observer dans la mélancolie :

- A- Écholalie
- B- Aproxexie
- C- Idées suicidaires
- D- Amaigrissement
- E- Constipation

Réponse : CDE

16) Concernant l'épisode maniaque :

- A- L'euphorie peut laisser place à l'irritabilité
- B- Une durée minimale d'une semaine est obligatoire pour retenir le diagnostic quel que soit la symptomatologie
- C- Le délire de grandeur est constant
- D- Les troubles du sommeil sont fréquents
- E- Les antécédents d'épisode dépressif est obligatoire pour porter le diagnostic de TB

Réponse : AD

17) Parmi les symptômes suivants, quel est celui ou quels sont ceux qui font partie de la mélancolie :

- A- L'inhibition psychomotrice marquée
- B- L'automatisme mental
- C- L'anxiété
- D- La douleur morale
- E- La dépersonnalisation

Réponse : AD

18) Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux qui ne voient pas dans un épisode maniaque :

- A- Logorrhée
- B- Conduites agressives
- C- Barrages
- D- Fugue
- E- Dissociation

Réponse : CE

19) Dans le cadre d'une inhibition psychomotrice profonde, quel (s) est (sont) le (s) symptôme (s) évocateur (s) d'une dépression mélancolique :

- A- La survenue au premier trimestre de grossesse
- B- Syndrome catatonique
- C- Sentiments d'incurabilité
- D- Réveil précoce
- E- Pessimisme permanent

Réponse : CDE

20) Comparativement aux bipolaires type I, les bipolaires type II :

- A- Font plus de tentative de suicide
- B- Font plus d'épisodes maniaques
- C- Sont surtout des femmes
- D- Font plus de récurrences
- E- Ont des rémissions de meilleure qualité

Réponse : ACD

21) Lors d'une dépression avec des caractéristiques mélancoliques, on peut rencontrer :

- A- Une anesthésie affective
- B- Un ralentissement psychomoteur important
- C- La présence de facteurs déclenchants
- D- La résistance aux antidépresseurs TC
- E- Une agitation

Réponse : ABE**22) Les antidépresseurs tricycliques de type imipraminique ont comme contre-indication(s) absolue(s) :**

- A- La maladie de Parkinson
- B- L'insuffisance respiratoire
- C- Le glaucome à angle fermé
- D- IDM récent
- E- Le diabète

Réponse : CD**23) Parmi les symptômes suivants quels sont ceux qui évoquent un EDM avec caractéristiques mélancoliques :**

- A- Insomnie mixte
- B- RPM marqué
- C- Aggravation vespérale
- D- Idées de culpabilité
- E- Perte de poids importante

Réponse : BDE**24) L'épisode maniaque comporte dans sa forme typique :**

- A- Une exaltation de l'humeur
- B- Des obsessions idéatives
- C- Un ralentissement psychomoteur
- D- Une insomnie
- E- Des hallucinations auditives

Réponse : AD**25) Parmi les symptômes suivants quels sont les plus habituels lors d'un EDC :**

- A- Humeur labile
- B- Idées obsédantes
- C- Perte des intérêts et des plaisirs
- D- Froideur affective
- E- Troubles de la concentration

Réponse : CE**26) Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome maniaque :**

- A- Fuite des pensées
- B- Thèmes délirants de culpabilité
- C- Achats inconsidérés
- D- Hyperactivité motrice désordonnée
- E- Humeur douloureuse

Réponse : ACD**27) Parmi les symptômes suivants quel(s) est (sont) celui (ceux) qui caractérise(nt) un EDC avec caractéristiques atypiques :**

- A- Les conduites toxicomaniaques et d'alcoolisation
- B- Une hypersomnie
- C- Une diminution de l'appétit
- D- Une tristesse de l'humeur
- E- Un délire de culpabilité

Réponse : B

28) Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) caractérise(nt) un syndrome maniaque :

- A- Il existe une anxiété diffuse permanente
- B- Les thèmes délirants s'ils existent sont le plus souvent de type mégalo-maniaque
- C- La culpabilité est habituelle
- D- La pensée est rapide et luxuriante
- E- Les actes médico-légaux sont à redouter

Réponse : **BDE**

29) Parmi les symptômes suivants, lequel (lesquels) appartient (appartiennent) au syndrome maniaque :

- A- Fuite des idées
- B- Agitation psychomotrice
- C- Jovialité et euphorie
- D- Insomnie
- E- Discordance

Réponse : **ABCD**

30) Lors d'une dépression masquée :

- A- L'altération de l'humeur est peu marquée
- B- Les idées de culpabilité sont fréquentes
- C- Un ou plusieurs symptômes somatiques sont au premier plan
- D- Le diagnostic est souvent tardif
- E- Le traitement de choix repose sur les benzodiazépines

Réponse : **ACD**

31) Les états maniaques francs aigus :

- A- Se voient dans la psychose maniaco-dépressive
- B- Sont une indication majeure au traitement par sels de Lithium
- C- Sont caractérisés par une exaltation euphorique de l'humeur
- D- Évoluent vers une détérioration intellectuelle
- E- Sont l'indication majeure des électrochocs

Réponse : **ABC**

32) Lors d'une dépression sur personnalité pathologique :

- A- Les troubles du sommeil sont à type d'insomnie d'endormissement
- B- Est une indication de la co-prescription de deux traitements antidépresseurs
- C- Fait suite à un événement psychologique traumatisant
- D- L'anxiété peut être intense avec des symptômes somatiques riches
- E- Le risque suicidaire est minime

Réponse : **ACD**

33) Parmi ceux-ci, quels sont les symptômes typiques d'un accès maniaque :

- A- Versatilité de l'humeur
- B- Excitation psychomotrice
- C- Hallucinations visuelles
- D- Hyperactivité désordonnée
- E- Insomnie

Réponse : **ABDE**

34) Une dépression symptomatique d'une étiologie organique :

- A- Survient à la suite d'un facteur déclenchant
- B- Survient chez des individus ayant une personnalité prédisposée
- C- Dépend de facteurs étiologiques génétiques
- D- Nécessite essentiellement un traitement antidépresseur et psychothérapeutique
- E- Répond bien au traitement étiologique

Réponse : **E**

35) Les antidépresseurs tricycliques peuvent entraîner :

- A- Une rétention urinaire
- B- Une bradycardie
- C- Des troubles du transit (constipation)
- D- Des syndromes extrapyramidaux
- E- Des dyskinésies tardives

Réponse : **AC**

36) Les dépressions sur personnalité pathologique :

- A- Apparaissent sur une personnalité psychotique
- B- Sont des dépressions psychogènes
- C- Le ralentissement est marqué
- D- Comportent des manifestations somatiques
- E- Surviennent au cours d'une schizophrénie

Réponse : **BD**

37) Au cours des 5 semaines qui font suite à un accouchement, on peut rencontrer :

- A- Une mélancolie puerpérale
- B- Le post-partum blues
- C- L'aggravation d'une schizophrénie préexistante
- D- Une décompensation névrotique
- E- Une dépression post natale

Réponse : **ABCD**

38) La mélancolie puerpérale :

- A- Est une forme modérée à début précoce (1^{er} mois)
- B- Le début est insidieux à partir d'un « post-partum blues » qui se prolonge
- C- Le risque d'infanticide est extrême
- D- L'évolution est marquée par la fréquence des récurrences et l'évolution bipolaire
- E- Son diagnostic est difficile

Réponse : **CD**

39) La conviction d'incurabilité est caractéristique de :

- A- La névrose obsessionnelle
- B- La névrose phobique
- C- La dépression réactionnelle
- D- La mélancolie
- E- La démence sénile

Réponse : **D**

40) Les signes cliniques suivants sont prédictifs de bipolarité chez un sujet déprimé :

- A- Caractéristiques atypiques
- B- Début tardif
- C- Anxiété marquée
- D- Nombre élevé d'épisodes dépressifs
- E- Sexe féminin

Réponse : **ACD**

41) Le traitement par le sel de Lithium :

- A- A comme indication majeure la prévention des accès maniaques et/ou dépressifs de la psychose maniacodépressive
- B- Est contre-indiqué chez la femme enceinte
- C- Nécessite la surveillance régulière de la fonction hépatique
- D- N'est efficace que si le taux de lithémie à jeun est supérieur à 0,6 mmol/l
- E- Ne peut pas être utilisé en association avec les antidépresseurs de type IMAO

Réponse : **ABD**

42) Au cours d'une mélancolie, les pensées suicidaires :

- A- Traduisent que le patient perçoit le suicide comme un dernier recours
- B- Sont toujours exprimées par le patient
- C- Influencent la décision thérapeutique
- D- Constituent souvent une indication d'hospitalisation
- E- Peuvent donner lieu à un acte suicidaire en début de traitement antidépresseur

Réponse : ACDE

43) Lequel de ces signes n'est pas habituellement relié à un surdosage en Lithium (prescrit dans une psychose maniaco-dépressive) :

- A- Nausées
- B- Dyspnée
- C- Tremblements
- D- Soif
- E- Trouble de l'équilibre

Réponse : B

44) Chez un malade déprimé, parmi les facteurs de risque suicidaire, on retient :

- A- L'isolement social
- B- La gravité de la dépression
- C- Les antécédents familiaux de suicide
- D- L'existence d'antécédents personnels d'accès maniaque
- E- L'existence d'un alcoolisme associé

Réponse : ABCDE

45) L'intoxication par le Lithium est révélée par :

- A- Vomissements
- B- Tremblements des membres supérieurs
- C- Troubles de l'équilibre
- D- Photophobie
- E- Confusion

Réponse : ABCE

46) Chez un malade déprimé parmi les éléments de risque suicidaire on note :

- A- Le sexe masculin
- B- La survenue à l'adolescence
- C- Les antécédents de confusion
- D- L'importance de l'anxiété
- E- L'existence d'une schizophrénie

Réponse : ABDE

47) On doit redouter particulièrement la réalisation d'une acte suicidaire au cours d'un EDC :

- A- La présence de caractéristiques mélancoliques
- B- La présence de caractéristiques psychotiques
- C- Devant une intention affirmée de se donner la mort
- D- L'existence de maladies somatiques associées
- E- L'accessibilité aux soins

Réponse : ABCD

48) L'estimation du passage à l'acte suicidaire peut être se faire par :

- A- Des échelles psychométriques
- B- Évaluation du risque suicidaire
- C- Évaluation de l'intentionnalité suicidaire
- D- Évaluation de l'urgence de la menace
- E- Évaluation du degré de dangerosité du scénario suicidaire

Réponse : ABDE

49) Une des propositions suivantes est une contre-indication à la prescription du Lithium chez un maniaque :

- A- Il s'est imposé un régime amaigrissant
- B- Il a fait une tentative de suicide
- C- Il suit un régime sans sel bien contrôlé par son médecin
- D- Il y a eu récemment un échec du traitement neuroleptique
- E- Il a une hypertension artérielle qu'il ne veut pas traiter

Réponse : C

50) Les symptômes suivants permettent de retenir le diagnostic d'une dépression délirante plutôt que celui d'une BDA :

- A- Un délire riche et polymorphe
- B- L'apparition de symptômes dépressifs avant les symptômes délirants
- C- Début brutal
- D- Un délire vécu intensément
- E- La prédominance des symptômes dépressifs par rapport au délire

Réponse : BE

51) L'accès maniaque dans sa forme typique comprend :

- A- Fuite des idées
- B- Instabilité motrice
- C- Logorrhée
- D- Euphorie permanente
- E- Automatisme mental

Réponse : ABC

52) Les antidépresseurs tricycliques sont susceptibles d'aggraver :

- A- Un glaucome à angle fermé
- B- Une insuffisance rénale
- C- Une hypothyroïdie
- D- Un adénome prostatique
- E- Une maladie de Parkinson

Réponse : AD

53) Les symptômes suivants caractérisent un épisode hypomaniaque :

- A- Augmentation de l'estime de soi
- B- Réduction du besoin de sommeil
- C- Troubles du comportement avec hétéroagressivité
- D- Délire de grandeur
- E- Plus grande communicabilité que d'habitude

Réponse : ABE

54) Outre la survenue d'accès maniaques et dépressifs, le trouble bipolaire est caractérisé par :

- A- Très nette prédominance masculine
- B- Il répond en général aux thérapeutiques par sels de lithium
- C- L'âge de début est habituellement tardif (après 60 ans)
- D- Dans les antécédents familiaux, on note la grande fréquence de l'éthylisme chez les hommes
- E- Le risque suicidaire est peu important

Réponse : B

55) Chez un patient qui fait un épisode mélancolique, quel est l'argument qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'une trouble bipolaire :

- A- Antécédents familiaux de suicide
- B- Antécédents familiaux de trouble bipolaire
- C- Antécédents personnels de manie
- D- Antécédents personnels de dépression mélancolique
- E- Absence de troubles psychiques intercritiques

Réponse : C

56) Le trouble bipolaire :

- A- Comporte des épisodes maniaques
- B- A souvent un caractère familial
- C- Est sensible à l'action prophylactique des sels de Lithium
- D- Débute le plus souvent après 50 ans
- E- Est plus fréquent chez les femmes

Réponse : **ABC**

57) Dans le DSM 5 le trouble bipolaire de type I est caractérisé par :

- A- Survenue obligatoire d'épisodes dépressifs
- B- Survenue obligatoire d'épisode maniaque
- C- Survenue obligatoire d'épisodes mixtes
- D- Survenue obligatoire d'épisodes hypomaniaques
- E- Exclusion des troubles de l'humeur induits par une substance

Réponse : **BE**

58) L'état maniaque dans sa forme typique comprend :

- A- Une fuite des idées
- B- Une hypermnésie
- C- Une logorrhée excessive
- D- Une forte anxiété permanente
- E- Un automatisme mental

Réponse : **ABC**

59) Le trouble bipolaire de type II est caractérisé par :

- A- Survenue au moins d'un épisode hypomaniaque et d'un EDC
- B- Survenue possible d'un épisode maniaque
- C- Survenue possible d'un épisode hypomaniaque avec caractéristiques psychotiques
- D- Exclusion des troubles de l'humeur induits par une substance
- E- Plus de récurrences et des rémissions plus faibles

Réponse : **ADE**

60) Quelles sont parmi les propositions suivantes celles qui constituent une complication du trouble bipolaire :

- A- La schizophrénie
- B- Les troubles de la personnalité
- C- Les conduites addictives
- D- Les troubles anxieux
- E- Les actes médico-légaux

Réponse : **CE**

61) Le risque suicidaire dans le trouble bipolaire :

- A- Est moins élevé que dans le trouble dépressif caractérisé
- B- Est plus élevé dans le TB de type I que le type II
- C- Augmente lors des ATCD familiaux de conduites suicidaires
- D- Diminue lors d'un virage maniaque sous antidépresseurs
- E- Augmente lorsqu'il y a des antécédents personnels de TS

Réponse : **CE**

62) Quel est parmi les éléments suivants celui qui permet de s'orienter vers le diagnostic d'un trouble bipolaire bientôt que celui d'un trouble schizo affectif :

- A- Existence d'ATCD familiaux de troubles de l'humeur
- B- Persistance de symptômes psychotiques entre les intervalles
- C- Association de symptômes thymiques et délirants
- D- Association de symptômes thymiques et dissociatifs
- E- Un intervalle libre de mauvaise qualité

Réponse : **A**

63) Dans une manie suraigüe, on peut rencontrer :

- A- Une agitation motrice prononcée
- B- Une dangerosité élevée
- C- Des éléments confusionnels surtout chez le sujet âgé
- D- Une catalepsie
- E- Des exigences de reconnaissance de droits

Réponse : ABE**64) Devant un malade déprimé, l'hospitalisation est indiquée :**

- A- En cas de soutien familial précaire
- B- En cas d'effets indésirables du traitement antidépresseur
- C- En cas de forme mélancolique de la dépression
- D- En cas d'idées suicidaires avérées
- E- En cas de ralentissement psychomoteur intense

Réponse : ACD**65) À propos du trouble dépressif récurrent :**

- A- Il est défini à partir de la survenue du 3^{ème} EDC
- B- Le lithium est indiqué en 2^{ème} intention
- C- Le traitement de maintenance est maintenu pendant 5 ans à partir du 2^{ème} EDC
- D- Le traitement antidépresseur utilisé dans la phase de consolidation doit être maintenu
- E- Le traitement antidépresseur est utilisé à la moitié de la dose initiale

Réponse : BD**66) Quels pathologies organiques peut prêter à confusion avec une dépression :**

- A- Une maladie d'Addison
- B- La syphilis tertiaire
- C- La Maladie de Parkinson
- D- Les tumeurs cérébrales
- E- Une hypothyroïdie

Réponse : ACDE**67) Le deuil se distingue de l'état dépressif par :**

- A- Les ruminations dépressives sont centrées sur l'être perdu
- B- Un vécu douloureux avec sentiment exclusif de culpabilité
- C- L'absence du ralentissement psychomoteur
- D- Fréquence des idées suicidaires
- E- La sensibilité à la réassurance et atténuation des symptômes avec le temps

Réponse : ACE**68) Un malade de 62 ans, déprimé, porteur d'un adénome de la prostate, nécessite un traitement antidépresseur.****Quel médicament choisissez-vous parmi les suivants :**

- A- TOFRANIL® (Imipramine)
- B- ELAVIL® (Amitriptyline)
- C- ZOLOFT® (Sertraline)
- D- LAROXYL® (Amitriptyline)
- E- ANAFRANIL® (Clomipramine)

Réponse : C**69) Quels éléments sont nécessaires pour surveiller un patient déprimé mis sous antidépresseurs ?**

- A- L'évolution de l'humeur
- B- Température
- C- Qualité du sommeil
- D- Signes de virage maniaque
- E- Risque de levée de l'inhibition

Réponse : ACDE

70) Quels éléments sont nécessaires pour surveiller un patient sous Lithium ?

- A- Bilan hépatique
- B- Symptômes thymiques
- C- Lithémie
- D- Signes neurologiques
- E- Signes digestifs

Réponse : BCDE

71) Parmi les molécules suivantes quelle est celle qui constitue le chef de file des thymorégulateurs ?

- A- Carbamazépine
- B- Quétiapine
- C- Valproate
- D- Sels de Lithium
- E- Lamotrigine

Réponse : D

72) Quels sont parmi les antipsychotiques suivants ceux qui ont des propriétés thymorégulatrices ?

- A- Chlorpromazine
- B- Olanzapine
- C- Halopéridol
- D- Quétiapine
- E- Aripiprazole

Réponse : BDE

73) Quelles sont parmi les explorations suivantes celles qui sont nécessaires avant d'instaurer un traitement par Lithium :

- A- Scanner cérébral
- B- Protéinurie de 24 heures
- C- β HCG
- D- Bilan hépatique
- E- Créat

Réponse : BCE

74) Parmi les thèmes délirants suivants, quels sont ceux qui évoquent un accès mélancolique :

- A- Incurabilité
- B- Mégalomanie
- C- Négation d'organe
- D- Influence
- E- Indignité

Réponse : ACE

75) L'EDC est caractérisé par les signes cliniques suivants sauf un, lequel :

- A- Trouble de sommeil
- B- Perte de poids
- C- Compulsion
- D- Ralentissement psychomoteur
- E- Humeur dépressive

Réponse : C

76) Parmi les troubles suivants, lequel constitue une complication du traitement par sels de Lithium :

- A- Insuffisance cardiaque
- B- Hypothyroïdie
- C- Phlébite des membres inférieurs
- D- Cholestase intra-hépatique
- E- Ulcère gastrique

Réponse : B

77) Un traitement par le Lithium est contre indiquée en cas de :

- A- Diabète sans complications
- B- Insuffisance rénale
- C- Grossesse (3 premiers mois)
- D- Hyperthyroïdie
- E- Ulcère gastro-duodénal

Réponse : BC

78) Parmi les incidents susceptibles de survenir au cours d'un traitement par les sels de Lithium, on doit retenir :

- A- Des accès de diarrhée
- B- Un syndrome polyuro-polydipsique
- C- Un amaigrissement
- D- Des céphalées
- E- Un tremblement digital

Réponse : ABE

79) Parmi les symptômes suivants, quel est celui ou quels sont ceux qui sont des signes de dépression :

- A- Désorientation temporo-spatiale
- B- Ralentissement psychomoteur
- C- Perte des intérêts
- D- Idées de ruine
- E- Besoin de vérifier ce qu'on vient de faire

Réponse : BCD

80) Chez un patient qui fait un épisode mélancolique, quel est l'argument qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un trouble bipolaire :

- A- Antécédents familiaux de suicide
- B- Antécédents familiaux de PMD
- C- Antécédents personnels de manie
- D- Antécédents personnels de dépression mélancolique
- E- Absence de troubles psychiques intercritiques

Réponse : C

81) Face à une inhibition psychomotrice profonde, quel (s) est (sont) le (s) symptôme (s) évocateur (s) d'une dépression mélancolique :

- A- Hallucinations visuelles
- B- Syndrome catatonique
- C- Sentiments d'incurabilité
- D- Insomnie avec éveil précoce à heure fixe
- E- Pessimisme permanent

Réponse : CDE

82) Le Lithium :

- A- Est un thymoanaleptique
- B- Est généralement efficace à une concentration plasmatique de 0.5 à 1 mmol par litre
- C- Est toxique vis-à-vis du système nerveux périphérique.
- D- Possède une toxicité accrue en cas d'hyponatrémie
- E- Doit être suspendu en cas de survenue d'une hypothyroïdie

Réponse : D

83) Parmi les diagnostics différentiel d'un épisode maniaque dans le cadre d'un trouble bipolaire :

- A- Les manies secondaires
- B- La confusion mentale
- C- Trouble délirant
- D- Trouble de la personnalité borderline
- E- Trouble schizo-affectif

Réponse : AB

84) Concernant le suicide dans le TB :

- A- Le risque suicidaire est plus important dans le trouble dépressif caractérisé que dans le TB
- B- Le risque est augmenté dans TB à cycles rapides
- C- Le risque est augmenté en début d'évolution
- D- Le risque est augmenté dans les épisodes avec caractéristiques mixtes
- E- Le risque est augmenté lors de la comorbidité avec des troubles anxieux

Réponse : **BCDE**

85) Concernant le TB :

- A- La durée des épisodes dépressifs est souvent supérieur à celle des épisodes maniaques
- B- La récurrence des épisodes thymiques augmente avec le nombre d'épisodes antérieurs
- C- La prescription d'antidépresseurs facilitent l'évolution vers un TB à cycles rapides
- D- Les épisodes dépressifs surviennent typiquement au printemps
- E- Les TB à caractère saisonnier sont plus fréquents chez les hommes

Réponse : **ABC**

86) La dépression de l'enfant :

- A- Elle est caractérisée par son grand polymorphisme
- B- L'instabilité prédomine sur le ralentissement psychomoteur
- C- Les idées et les équivalents suicidaires suffisent pour retenir le diagnostic d'un EDC
- D- Les troubles sphinctériens ne sont pas rencontrés
- E- Les troubles de conduites peuvent être présents

Réponse : **ABE**

87) La dépression de l'adolescent :

- A- L'irritabilité est généralement absente
- B- Des plaintes somatiques également peuvent être au-devant du tableau
- C- Les formes avec troubles de conduites sont plus fréquentes chez les garçons
- D- Les troubles du sommeil et de l'appétit sont moins fréquents que chez l'enfant déprimé
- E- Les automutilations sont fréquents chez l'adolescent déprimé

Réponse : **BCE**

Cas clinique N°1

Madame D, 29 ans est ramenée par son mari pour insomnie totale évoluant depuis 07 jours.

Elle se déplace beaucoup, elle s'exprime avec un débit verbal accéléré et déclare ne plus avoir besoin ni de manger, ni de boire, ni de dormir. "Je peux tout entreprendre et tout réussir" dit-elle.

Elle a agressé une voisine qui lui a reproché le bruit qu'elle fait la nuit.

Le mari précise qu'il y a quelques années, après la naissance de leur deuxième fille, sa femme avait des "idées noires", refusait toute visite et toute sortie.

Cette symptomatologie était spontanément résolutive en 01 mois.

L'examen physique actuel est normal.

1- Quel est le type de l'épisode actuel ?

Épisode maniaque

2- Quelle est votre conduite en urgence?

Hospitalisation dans un service de psychiatrie

3- Quel est le type de traitement indiqué en première intention pour cette patiente?

Thymorégulateurs - normothymiques – stabilisateurs de l'humeur

Cas clinique N°2

Madame A.T âgée de 30 ans, aux antécédents d'un EDC, consulte pour insomnie.

Son mari rapporte qu'elle est devenue bavarde, cherchant tout le temps le contact avec les autres, plus active chez elle malgré le manque de sommeil et faisant les boutiques plus souvent qu'à son habitude.

Ceci évoluait depuis 4 jours et à chaque fois qu'on lui faisait la remarque, elle s'énervait rapidement.

Il signale également qu'après son dernier accouchement il y a 7 ans, elle pleurait souvent, elle ne supportait plus les cris de leur bébé et elle n'arrivait plus à s'occuper de lui.

Elle se sentait fatiguée et elle a sensiblement maigri.

Cette symptomatologie s'est améliorée spontanément au bout de 2 mois.

1- Quel est le type de l'épisode actuel ?

Épisode hypomaniaque

2- Dans quel trouble s'inscrit cet épisode?

TB Type II

3- Quel est le traitement indiqué pour cette patiente ?

Un thymorégulateur

Cas clinique N°3

Monsieur B.A âgé de 45 ans consulte pour insomnie.

Depuis 1 mois, il se sentait vidé de son énergie, il ne parlait que peu, il préférait rester seul et il avait les larmes au bout des yeux.

Au travail, il n'arrivait plus à se concentrer, il commettait ainsi beaucoup d'erreurs et ses collègues ont constaté qu'il est devenu tendu et irritable et qu'il a perdu son sens de l'humour habituel.

Dans ses antécédents familiaux, il a un cousin qui s'est suicidé au jeune âge.

L'examen somatique est strictement normal.

1- Quel est votre diagnostic ?

EDC

2- Relevez les quatre signes cliniques en faveur de ce diagnostic

- Humeur triste
- Insomnie
- ATCDs familiaux de suicide
- Symptomatologie depuis 1 mois ++

3- Quel traitement médicamenteux de première intention lui proposez-vous ? (la classe pharmacologique et la molécule)

ISRS : Paroxétine 20 mg/j

4- Après rémission symptomatique, pour quelle durée minimale ce traitement doit être poursuivi ?

6 mois au minimum après rémission

Après 3 semaines de traitement, le patient reconsulte accompagné par sa femme.

Cette dernière a signalé qu'il y a eu une accentuation de l'irritabilité chez lui avec un passage à l'acte agressif.

Il ne dormait quasiment plus, il est devenu très bavard et instable et il a fait beaucoup d'achats inutiles ces derniers jours.

5- Dans quel trouble (DSM-5) s'inscrit l'épisode dépressif initial ?

Trouble Bipolaire

6- Quelle est la première attitude thérapeutique que vous allez adopter

Arrêt du traitement antidépresseur

7- Quel traitement médicamenteux de première intention proposez-vous dans ce cas?

Thymorégulateur

Cas clinique N°4

Madame X, 34 ans, mariée, mère de deux enfants, avait présenté dans les suites de son premier accouchement une épisode confuso-onirique aigu qui avait nécessité l'hospitalisation pendant une quinzaine de jours et un traitement neuroleptique. Sa mère et sa grand-mère maternelle ont présenté chacune deux épisodes dépressifs graves. Elle vient consulter à la demande de sa famille pour une excitation, des activités désordonnées et une insomnie. L'examen physique ne met en évidence aucune anomalie. L'humeur est euphorique avec une sub-excitation psychique mais sans trouble majeur du comportement, le débit verbal est accéléré.

1- Dans quel cadre clinique se situe un tel état :

- A- Hystérie
- B- Schizophrénie
- C- Trouble bipolaire
- D- Bouffée délirante
- E- Psychopathie

Réponse : C

2- Parmi les psychotropes suivants quelle (s) catégorie (s) de médicaments vous paraissent les plus indiquées pour le traitement ou la prévention :

- A- Benzodiazépines
- B- Antipsychotiques atypiques
- C- Antidépresseurs
- D- Antithyroïdiens de synthèse
- E- Sels de Lithium

Réponse : BE

3- Parmi les cinq chiffres suivants, quel est le chiffre de lithiémie efficace à obtenir pour un traitement prophylactique :

- A- 0,2 mEq/l
- B- 0,4 mEq/l
- C- 0,8 mEq/l
- D- 1,3 mEq/l
- E- 1,7 mEq/l

Réponse : C

4- À partir de quel chiffre de lithiémie sanguine y a-t-il un risque de toxicité :

- A- 0,4 mEq/l
- B- 0,8 mEq/l
- C- 0,9 mEq/l
- D- 1,3 mEq/l
- E- 1,6 mEq/l

Réponse : D

5- Compte tenu des risques liés à un tel traitement, une précaution est souhaitable. Laquelle :

- A- Tonicardiaque
- B- Diurétique
- C- Mise en œuvre d'une contraception
- D- Vitaminothérapie
- E- Extraits thyroïdiens

Réponse : C

6- Dans la perspective de l'institution de ce traitement, quels sont parmi les 5 examens suivants ceux qui sont indispensables à pratiquer :

- A- Calcémie
- B- Bilan hépatique
- C- Bilan thyroïdien
- D- Bilan rénal
- E- Frottis vaginaux

Réponse : ACD

Cas clinique N° 5 :

Mme L., âgée de 81 ans vous est adressée pour altération de l'état général, avec adynamie et lombalgies; elle semble actuellement très dépressive elle pleure souvent.

Elle est en arythmie et a un glaucome

Son traitement actuel associe Risordan® et Aldactazine®.

À l'entretien, elle déclare: « Donnez-moi une pilule pour rejoindre mon mari et mon fils, j'ai trop mal au dos, je suis une bouche inutile pour la société ».

On apprend qu'ils sont décédés, il y a quelques années.

L'examen somatique est normal hormis l'arythmie. Les examens complémentaires sont normaux.

1- Quel (s) est (sont) le (s) symptôme(s) présent (s) dans cette observation :

- A- Des idées de suicide
- B- Une auto-accusation
- C- Un sentiment de dévalorisation
- D- Des plaintes hypochondriaques
- E- Des plaintes somatiques

Réponse : ACE

2- Quel (s) est (sont) le (s) risque (s) évolutif (s) possible (s) en l'absence de traitement :

- A- Un état grabataire
- B- Des automutilations
- C- Un accès maniaque
- D- Un suicide
- E- Une attaque de panique

Réponse : AD

3- Quel est le psychotrope que vous proposez en monothérapie :

- A- Amitriptyline (Laroxyl®)
- B- Chlorpromazine (Largacil®)
- C- Sertraline (Zoloft®)
- D- Trioridazine (Melleril®)
- E- Clomipramine (Anafranil®)

Réponse : C

Cas clinique N° 6 :

Mme F âgée de 66 ans, institutrice à la retraite, consulte pour des troubles de la mémoire d'apparition progressive depuis quelques mois.

C'est son époux qui attire l'attention sur ses troubles, car il constate qu'il doit lui répéter plusieurs fois des questions simples.

Il rapporte que depuis quelques mois, elle restreint considérablement ses activités, tant domestiques, qu'extérieures.

Il a notamment relevé l'altération de la qualité des repas.

À l'interrogatoire elle ne finit pas ses phrases et on observe un manque du mot.

Elle exprime par ailleurs un désintérêt pour ses activités, se montre craintive pour l'avenir, pleure facilement, se dit fatiguée.

Son mari signale qu'elle a besoin d'aide pour s'habiller convenablement.

Aucun antécédent particulier n'est à relever et aucune pathologie familiale n'est connue.

1- Quels symptômes peut-on relever dans cette observation ?

- Début progressif chez un sujet âgé sans antécédents médico-psychiatriques ou familiaux de : Troubles mnésiques, anorexie, ralentissement psychomoteur, asthénie, apathie, humeur dépressive, pleurs, désintérêt, diminution des capacités intellectuelles, troubles du langage, manque de mot, aphasie débutante, apraxie.

2- Discutez le diagnostic nosographique :

Syndrome démentiel et/ou syndrome dépressif

3- Quel projet thérapeutique peut-on envisager ?

Traitement antidépresseur d'épreuve

Cas clinique N° 7 :

Mr N., âgé de 60 ans vous a été adressé d'un service de réanimation suite à une tentative de suicide par IMV.

Vous apprenez qu'il est sans enfants et qu'il vit seul depuis le décès de sa femme (par cancer de sein) dans des conditions socio-économiques modestes.

Il est suivi depuis des années pour un diabète et pour un trouble dépressif récurrent.

Le patient n'a jamais été bon observant thérapeutique.

À L'entretien la patient est ralenti, la mimique est pauvre, le discours est provoqué.

Le patient rapporte qu'il a été à l'origine du décès de sa femme, qu'il mérite le châtiment suprême et qu'il est damné pour le reste de son existence, que cela ne servira à rien de lui donner un traitement, puisque de toute manière il n'a plus d'estomac, ni de veines et qu'il désire de mettre terme à tout cela.

1- Ce patient présente :

- A- Une dissociation
- B- Une dissocation
- C- Une bradykinésie
- D- Une bradypsychie
- E- Un délire de Cotard

Réponse : CDE

2- Quelle forme clinique de dépression présente ce patient

- A- Dépression exogène
- B- Dépression avec des éléments de mixité
- C- Dépression névrotico-réactionnelle
- D- Mélancolie délirante
- E- Dépression sur personnalité pathologique

Réponse : D

3- Quelle est la meilleure conduite à tenir pour ce patient :

- A- Anafranil 350 mg/j
- B- Halopéridol 10 mg/j + Paroxétine 20 mg/j
- C- Sismothérapie (ECT)
- D- Sertraline 20mg/j + Risperidone 2mg/j
- E- Sertraline 40 mg/j + Halopéridol

Réponse : C